



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : نجلاء علي فضلون غيضان
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : المطرية العنوان : =
رقم البطاقة : 28412262300848 رقم التليفون : 01095178357 تاريخ تسجيل الإستمارة : 30-09-2026
العمر (تاريخ الميلاد) : 26-12-1984 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي (.....)
المقر بما فيه التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

Name: نجلاء علي فضلون غيثان
National ID: 28412762300848



تقرير طبي

المسيد

تحية طيبة وبعد,,

بشان تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ وساعة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ وساعة الدخول :
-- -- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالبدن و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

الوقت :

-- --

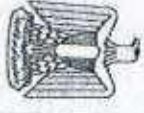
التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين


 جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحقيق الشخصية
 نجلاء
 علي فضلون غنيم
 المبروك جدي
 مركز يوسف الصديق - القاهرة
 ٢٨٤١٢٢٦٢٣٠٠٨٤٨
 IK5845952

OMS
 ميناكاسي


 ٢٠٢٠/٠٩
 ٢٨٤١٢٢٦٢٣٠٠٨٤٨
 حاصلة على بطون تجارة
 انش
 مطاوع عبد المجيد خليله فرج الله
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٩/٠٩



Patient Name :	الأمستاده / نجلاء علي فضلون محيطان	Request No. :	13005428
Patient No. :	28412262300848	Request Date :	12/03/2026
Path No. :	690/26	Verification Date :	23/03/2026
Sex :	Female	Financial Category :	جوسناف رومسي - نفقة الدولة
Age :	41 Y	Department :	Out Patient
Referring Doc :		Registered by :	.marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Recurrent left breast invasive duct carcinoma, Post-NACT.
Nature of specimen: Left completion mastectomy.

Gross examination:

Left completion mastectomy specimen measured 20x17x5 cm, with covering skin ellipse measured 18x12 cm. Nipple & areola looked unremarkable grossly. Serialing showed a tumor bed site measured 7x5x3 cm, located 2 cm from the deep margin.

12 Blocks:

1:10- TBS., 11- N&A., 12- Deep margin.

Microscopic Examination:

- * Histological type: No residual viable remnants of the previously diagnosed invasive tumor.
- Cellularity (0%).
- * Angiolinvasion: Absent.
- * Ductal carcinoma in situ: Absent.
- * Additional findings: Effect of therapy with microcalcifications.
- * Deep margin: Free.
- * Histologic response to therapy: Pathological complete response to therapy.

Diagnosis:

- Recurrent left breast cancer (Post-NACT), Left completion mastectomy:
- No residual viable remnants of the previously diagnosed invasive tumor.
 - Ductal carcinoma in situ: Absent.
 - Deep margin: Free.
 - Histologic response to therapy: Pathological complete response to therapy.
 - Stage: ypT0.

Signature

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 31/03/2026 10:29:53

Page 1 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Name: نجلاء على فضلون غيضان		
MR. : 3659		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها		
LOCALLY RECURENT LEFT BREAST CANCER ER-VE PR-VE HER23+ REC 6 TAXOTERE CARBOPLATIN ,SURGERY PENDING EF 12/2025 63% FOR C6 HERCEPTIN SC HISTORY 2020 5/2025 LEFT BCS T2 N1 3/13 REC 4 AC 4 TH REC ADJ HERCEPTIN TILL 2021 LOCAL RECCURENCE IN 2025 HERCEPTIN SC C8 HERCEPTIN C9 AND 10 SC PHARMACY PLEASE ADD PARACETAMOL AND THANK U ;* pt did left completion mastectomy on 12/3/2026 cr ypto mdt on 7/4/2026 for adj herceptin sc for 1 year for c9 herceptin 600 sc for us left chest wall and axilla sm 4/7/2026 rt breast stabe benign lesion birads 2 ef 63% on 18/7/2026 for c12 herceptin sc adjuvant c13 herceptin sc adjuvant add methylrechno C14 , C15 herceptin. The patient has completed 15 cycles of HERCEPTIN SC.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 21-09-2026
	الطبيب المعالج : dina makram	
يعتمد ,		

Patient Name : الأستاذ / نجلاء علي فضالون غيطان
Patient No. : 28412262300848
Path No. : 690/26
Sex : Female
Age : 41 Y
Referring Doc :

Request No. : 13005428
Request Date : 12/03/2026
Verification Date : 23/03/2026
Financial Category : جوستاف روسي - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.
Dr. Heba El-Shafeey.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 31/03/2026 10:29:53

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

04/07/2026

MDT FORM

Name:	Najlas Ali Fadioun Ghedan	MRN:	3659
Age:	41 Y	ID:	28412262300848
Menopausal Status:	PRE	Phone:	01068470221
NRS SCORE:	PS 1	Marital Status:	MARRIED
BMI:		Family History:	-VE
CO Morbidity:	NAD	Reason Of MDT:	POST OP

Clinical Data:

BX: IDC G2
ER 0/8 PR 0/8 HER +3 KI67 50

Sonomammography:

LT RECURRENT BREAST CANCER

Meta Workup:

History:

POST NACT ,
HISTORY OF LT BREAST BCS AND ALND WITH MINI
LD FLAP IN 2020 OUTSIDE AND ADJ TTT WITH PORT

Recommendations:

LT COMPLETION MASTECTOMY FOR RECURRENT
BREAST CANCER AFTER NACT PCR TO

MDT Outcome & Plan

For Adjuvant Herceptin up to 1 year.

R

L



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/ خالد عبد العزيز	د/ محمد التبروي	د/ نور بكر حجازي			

جمعية خيرية
بطاقة تحقيق الشخصية



نجلاء
على فضلون غيضان
المشرك بحري
مركز يوسف الصديق - الفيوم

٢ ٨٤ ١٢ ٢٦ ٢٣ ٠٠٨ ٤٨

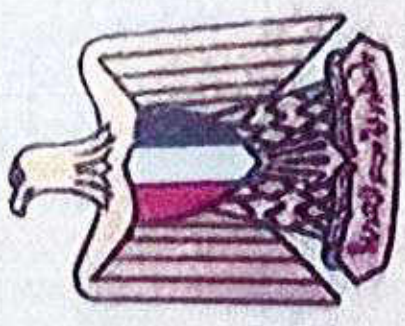


IK5845952

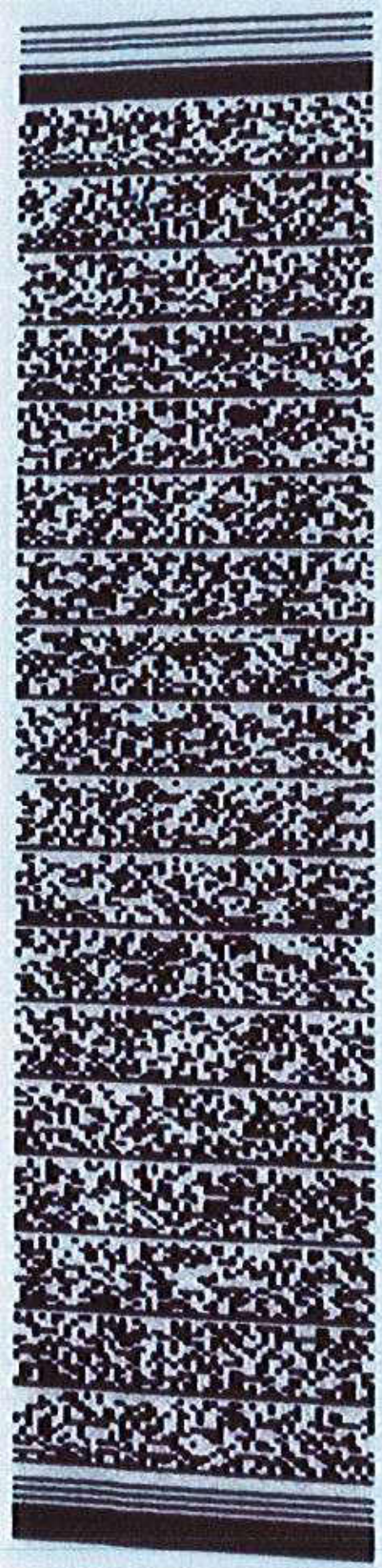


٢٠٢٠/٠٦ ٢٨٤١٢٢٦٢٣٠٠٨٤٨

حاصلة على دبلوم تجاره



متزوجة
مسلمة
انثى
مطووع عبد المجيد خليفه فرج الله
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٦/٠٩



HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات والتحول
الرقمي

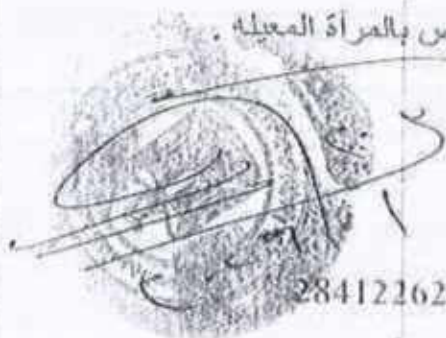
رسوم الاستعلام 20 جنية

جهة الاصدار: فرع اليوم

تاريخ الاصدار: 2026-1-20

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
و البحث تبين أن

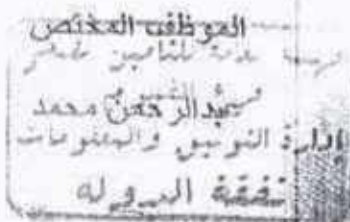


السيد (ة) نجلاء علي فضلون غيضان بطاقة رقم 28412262300848

تليفون رقم: 01095178356

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة: 2026-1-20



أفاد مركز نظم المعلومات
بعمد...

مستلم 1884842



الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار الا في حالة تغيير حالة المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات والتحول الرقمي



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الست المظفرة
شاهين
طه
مطر

MDT FORM

26/8/2025 G

Name	د. محمد حسن	MRN	010100000000000000
Age	40	ID	217612020
Menopausal status	Pre	Phone	01066470221
NRS SCORE		Marital status	married
BMI		Family history	none
CO morbidity	- moderately fit - Lt Breast (2020) Post (Hormone)	REASON OF MDT	Re MDT

Clinical Data

BX: IDCTI (recurrent) R

ER: 018 PR: 018 HER 2: 5+ KI67: 50%

Sonomammography: CESM → Post (Hormone) with 400 mass

Mets Workup: 2x1 cm

PAWS → line
CT CAP negative → free

Recommendations: Bone SC → negative → free
- Pt needs Post. cath

Dr. Hosh
26/8/2025

MDT OUTCOME & PLAN

- NATCUP X6
- Clipping Then WLE

- Post-op re-irradiation
(75G)

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
H. Kell					

ب. ش. ش. ش.

JUSTAVE
BOUSSY

Patient Name : الاستاذ / تجلاء علي مصطفى غوطان
Patient No. : 28412262300848
Path No. : 2444/25
Sex : Female
Age : 40 Y
Referring Doc :

Request No. : 13009911
Request Date : 04/08/2025
Verification Date : 07/08/2025
Financial Category : جوستاف روسي - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast lesion after left conservative surgery, BIRADs 4B.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 03/08/2025.

Gross Examination:

- Four grey white tissue cores, the longest was 1.5 cm. Totally submitted.

Technique:

- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Meridian) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5) & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade 2 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).
- * DCIS: Absent.
- * Angioinvasion: Absent.
- * Perineural invasion: Absent.
- * Microcalcification: Present.
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
 - ER: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
 - PR: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
 - Her2: Strong complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 3+).
 - Ki67: 50%.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

Verified by :
Dr. Duaa Mohamed

Printing Date : 14/08/2025 10:42:06

Page 1 of 3

Printing By : Mrs. Mayada Hegazy

CAP

غرفة رقم (4) - الدور الاول - مبنى رقم 987 - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. 14 - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

ant Name : الأستاذ / فجلأ على فضلون غيطان
atient No. : 28412262300848
Path No. : 2444/25
Sex : Female
Age : 40 Y
Referring Doc :

Request No. : 13009911
Request Date : 04/08/2025
Verification Date : 07/08/2025
Financial Category : نفقة الدولة - جوستاف روسي
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

IPT:

- ER: Negative (score 0/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67%: 50%.

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%

and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.
D. Heba El-Shafeey.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 14/08/2025 10:42:06

Page 2 of 3

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name : الاستاذة / نجلاء على فضلون غيطان
Patient No. : 28412262300848
Path No : 2444/25
Sex : Female
Age : 40 Y
Referring Doc :

Request No. : 13009911
Request Date : 04/08/2025
Verification Date : 07/08/2025
Financial Category : جوسلفه روسمي - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Verified by :
Dr. Duaa Mohamed

Printing Date : 14/08/2025 10:42:06

Page 3 of 3

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy

PATIENT NAME: NAGLAA ALI Fadlon GHEDAN

GENDER: Female

DATE : 02-Aug-2025 03:42 PM

PATIENT ID: 2020141817

AGE: 40 y

ORDER: 3497505,3498372

CONTRAST ENHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHY

INDICATION:

- Left BCS 5 years ago
- Left palpable lump
- Right axillary tail pathological proven firboadenoma

TECHNIQUE:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography CC and MLO views
- IV non-ionic contrast medium infusion 100 ml of omnipaque

REPORT:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography showed right moderate asymmetrical back ground nodular parenchymal enhancement.

Left breast :

- UOQ and axillary distorted contour owed to previous conservative surgery showing minimal back ground parenchymal enhancement.
- UOQ operative bed intense heterogenous mass enhancement measuirng 2x0.9 cm ,located 3 cm from nipple corresponding by ultrasound to irregular hypoechoic solid mass lesion seen at 2 o'clock along course of old scar tissue

Right breast :

- Axillary tail homogenous mass enhancement more appreciated in MLO view corresponding by ultrasound to circumscribed isoechoic lesion with subtle marginal irregularities measuirng 2x1.2 cm (previous biopsied outside proven firboadenoma)
- Another LIQ moderate mass enhancement seen 7.2 cm from nipple corresponding by ultrasound to 2-3 o'clock well circumscribed hypoechoic mass lesion measuirng 1.2x0.7 cm
- LIQ assymtrical non mass enhancement corresponding to adenotic parenchyma with no correlated suspicious lesions
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.

OPINION:

Left breast :s/p BCS with UOQ operative bed suspicious mass enhancement

PATIENT: NAGLAA ALI Fadlon GHEDAN, 2020141817, Female, 40 y

Report version 1, 02-Aug-2025 05:43 PM

Page 1 of 2



www.Baheya.org



16602

مركز بهية الشرق
4 شارع علوية بول شارع اليوم بجوار داري الجيزة

مستشفى بهية المشيخ زايد
100 شارع الأولى، الشيخ زايد أمام كلية الهندسة

as described for histopathological correlation (BIRADS 4).

Right breast :

- LIQ non mass assymtrical enhancement likely glandular summation
- 2 probably benign mass enhancement as described likely fibroadenomata

For follow up after 6 months (BIRADS 3)

Reported By,

Dr. Lamiaa H.El Malatwy, MSc

02-Aug-2025 05:43 PM

PATIENT: NAGLAA ALI Fadion GHEDAN, 2020141817, Female, 40 y

Report version 1, 02-Aug-2025 05:43 PM

Page 2 of 2



www.Baheya.org



16602

مركز بنية اليرمو
و شارع عادية اول شارع اليرمو بجوار داري الجيزة



د. مصطفى يوسف الشاذلي
رئيس اللجنة الطبية في مستشفى



Patient Name: Naglaa Ali Fadlon Gaidan
Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS
Medical ID: 2178/2020

Date : 22/06/2025
Age : 39 Year(s)
Pat. ID: 11301

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Average in size (15cm at Rt MCL) homogenous parenchymal echopattern with smooth surface.
- No hepatic focal lesions or intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is patent and not dilated.

Gall Bladder: -

- Average distention and capacity with no stones or mud
- The wall is not thickened.
- CBD is not dilated.

Spleen: -

- Average size, homogenous.

Kidneys: -

- Both are average in size, shape and echogenicity
- No stones or dilated pelvicalyceal system
- No gross lesion

Para-aortic and pancreatic area: show no gross abnormalities.

No ascites

Urinary Bladder: -

- Average capacity with no stones or diverticular out pouching

Uterus and adnexal: no abnormalities could be detected, IUCD is in place

Opinion:

Unremarkable study

Signature Dr . Nermien Ramadan

22/06/2025 1:25 PM

Name : Najlaa Ali Fadloun Ghaydan

Branch : Dokki

Ref. Physician Prof : Gostaf Roseh Hospital

Date : 21-08-2025 12:49

Medical No. : 182829

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History:

- A 40-year-old lady, with history of left breast cancer.

Technique:

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings:

- No abnormal active or cold focal bony lesions could be seen over the surveyed skeleton to account for metastatic bone disease.
- Degenerative changes are seen at the spine and big joints.

Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Much oblige
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear medicine

Patient Name: Naglaa Ali Fadlon Gaidan	Date : 17/08/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 39 Year(s)
Medical ID: 2178/2020	Pat. ID: 11301

OST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

Reported case of breast cancer .

Chest:-

- > Part of both breast are out of field of examination.
- > bilateral axillary lymphadenopathy likely reactive .
- > Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitory lesions.
- > No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- > No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- > Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.

Abdomen & pelvis:

- > The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions .
- > No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- > Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- > Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- > Normal appearance of the pancreas and both suprarenals.
- > Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- > Normal appearance of the other pelvic organs.
- > No abdominal or pelvic masses or collections.
- > IUCD in place .
- > Examined bones show : at right SIJ subchondral cysts at sacral side likely part of sacroiliitis.

Opinion:

- > No hepatic or pulmonary metastatic deposits.
- > Right sacral subchondral cystic changes likely part of sacroiliitis for correlation with bone scan.

DR/Reham Khedr ,,,MD

Signature Reeham.Khader
19/08/2025 11:41 PM
Signature Reeham.Khader
19/08/2025 11:41 PM

Patient Name: Naglaa Ali Fadlon Gaidan	Date : 26/07/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 39 Year(s)
Medical ID: 2176/2020	Pat. ID: 11301

BILATERAL MAMMOGRAM AND BREAST ULTRASONOGRAPHY REVEALED:

Indication: Follow up after left conservative surgery.

- **Breast density:** Extreme dense breast tissue. **Matching ACR D.**
- Thickened left breast skin with focal asymmetry is seen in the left upper outer quadrant with fairly circumscribed lesions seen in the left UOQ..
- No detected definite suspicious masses, architectural distortion or pathological calcifications in the right breast.
- Normal skin and nipple in the right breast.

By complementary bilateral breast ultrasound:

- Heterogeneous (predominantly glandular) parenchymal echo-texture.
- Fairly circumscribed margin lesion is seen in the left breast at 3 o'clock ,zone 1 ,measuring (10 x 19 mm)..
- Two well circumscribed lesions are seen in the right breast at 2 o'clock ,zone 1, measuring (10 x 9 mm) and in the right axillary region measuring (17 x 10 mm)..
- No detected significant axillary lymph nodes.

CONCLUSION:

- **Left breast :** Post conservative surgery changes of the left breast with UOQ Indeterminate nature lesion (BIRADS 4A Category).
- **Right breast :** Two right probably benign looking lesions (BIRADS 3 Category).

Much Obligated

DR.MONA ZAKY,MD

Professor of diagnostic radiology-Breast imaging unit -Mansoura University

Signature Dr. Mona Zaki

26/07/2025 4:34 PM

Naglaa Ali Fadlon

8/1/2026

**Digitalized Low Dose Soft Tissue Mammography With
Complementary Breast US Examination Of Both Breasts Revealed:
S/P NCTH for recurrent Lt breast cancer post CBS**

Left breast:

S/P CBS showing

- No speculated mass lesions or clustered microcalcification
- On US UOQ 2 o'clock paraareolar residual hypoechoic distortion over area 1.7 x 0.6 cm
- No pathological axillary / supraclavicular LNs .

Right breast:

- ACR D: extremely dense breast parenchyma may obscure underlying lesions
- No spiculated mass lesions or clustered microcalcification
- On US there is two circumscribed isoechoic masses are seen at axillary tail measuring 1.1 x 0.7 cm and at 2 o'clock measuring 0.5 x 0.7 cm
- Normal skin thickness and contour as well as nipple areola complexes.
- Non specific axillary lymph nodes showing preserved fatty hila.

Opinion:

- S/P NCTH for recurrent Lt breast cancer showing residual UOQ distortion (BIRADFS 6)
- Rt axillary tail and UIQ probably benign lesions likely fibroadenomata (BIRADS 3),

*Best regards,
Dr. Radwa Magdy
Breast Imaging Consultant,
NCI, Cairo University*